

Observation et étude de cas

*Méthodologie
phénoménologie / analyse existentielle*

PHILIPPE SPOLJAR

Courriel : philippe.spoljar@u-picardie.fr

Présentation : objectifs des TD

L'enjeu des TD va être de transformer la méthode en savoir-faire concret, en pratiquant progressivement chacune des étapes.

Types de supports utilisables, pour varier les apprentissages :

- vignettes cliniques
- extraits d'entretien
- récits autobiographiques
- textes littéraires

À la fin des TD, il faut être capable de :

- suspendre le diagnostic
- décrire un vécu
- l'organiser selon les existentiels
- identifier une tension structurante
- formuler une structure de vécu

Consignes générales :

- ne pas utiliser de catégories sémiologiques / psychopathologiques
- rester au plus près du texte
- éviter toute interprétation « psychologique » ou diagnostique
- utiliser des formulations descriptives

Formulations à éviter :

- « il est anxieux »
- « elle a un trouble de... »
- « il manque de confiance »

Formulations attendues :

- « la situation est vécue comme... »
- « le monde apparaît comme... »
- « le corps est mobilisé de telle manière... »

Critères d'évaluation :

- Fidélité au matériau : les analyses sont ancrées dans le texte
- Respect de la posture phénoménologique : absence de diagnostic ou d'explication causale
- Qualité descriptive : précision, finesse, rigueur
- Organisation du matériau : utilisation pertinente des dimensions du vécu
- Pertinence des tensions : caractère transversal et dynamique
- > Cohérence de la structure de vécu : synthèse claire et articulée

Objectifs : Entrer dans la posture de la clinique phénoménologique

- Comprendre concrètement l'épochè clinique
- Distinguer description / interprétation / diagnostic

Travail en binôme :

- relecture critique
- vérification de l'ancrage textuel
- comparaison de plusieurs structures (validité intersubjective)
- > production finale > une mini étude de cas complète

Principes de l'analyse phénoménologique (synthèse)

L'analyse phénoménologique d'un cas clinique vise à comprendre comment une existence se tient, à partir de la manière dont elle est vécue. Elle repose sur quatre étapes successives, qui doivent rester distinctes.

1. Décrire le vécu (repérage phénoménologique)

Question directrice : *Comment cette personne vit-elle ce qu'elle vit (tel que cela apparaît dans le texte) ?*

> On relève uniquement (sans interpréter, sans diagnostiquer, sans expliquer) :

les formulations subjectives

les affects, les perceptions, les gestes, les images

les rythmes, bascules, répétitions

les indices cliniques temporels, spatiaux, corporels, attentionnels, ...

2. Organiser selon les dimensions de l'existence (existenciaux), selon les dimensions suivantes :

Corps (corporéité)

Temps (temporalité)

Espace (spatialité)

Soi (ipséité)

Autre (altérité)

Monde (mondanéité)

Pour chacune de ces dimensions, il faut :

- rassembler les indices cliniques pertinents

- puis indiquer "l'organisation du vécu" dans cette dimension

> Objectif : donner une lisibilité structurée au vécu, sans réduire ni découper artificiellement

3. Dégager les tensions structurantes

Une tension structurante est : une polarité dynamique, transversale (présente dans plusieurs dimensions)

Il peut y avoir plusieurs tensions organisatrice de la structure du vécu

Chacun des pôles (parfois il n'y en a qu'un seul) peut être commenté de façon plus détaillée

Il faut indiquer :

- ce que cette organisation *permet*

- et ce qu'elle *limite*

Une tension est *valide* si :

- elle traverse plusieurs dimensions

- elle n'est pas un synonyme d'une autre tension

- elle permet ET limite
- elle n'est ni un trait, ni un déficit

(Hiérarchie possible entre tension principale et secondaire/dérivée pour éviter les listes plates)

4. *Formuler la structure de vécu*, de manière synthétique, qui rend compte :

- de la cohérence du vécu
 - de sa logique existentielle
 - de la manière dont le sujet se maintient dans l'existence
- > ceci en articulant plusieurs dimensions (sans diagnostic, sans causalité, sans jugement)

> Principe directeur : on ne cherche pas

- ce que le sujet « est »
- ce que le sujet « a »
- mais : ce qu'il vit, et comment il existe

Formalisation

Etape 1 - Matériau clinique « brut »

Consigne : relever les éléments cliniques du vécu tels qu'ils apparaissent dans le texte (sans interprétation)

Indices cliniques :

-
-
-
-
-

Organisation du vécu (1 phrase) : Le vécu semble s'organiser autour de :

.....

Etape 2 - Organisation selon les dimensions (existenciaux)

Corporéité

Indices cliniques :

-
-
-

Organisation du vécu :

.....

Temporalité

Indices cliniques :

-
-
-

Organisation du vécu :

.....

Spatialité

Indices cliniques :

-
-
-

Organisation du vécu :

.....

Altérité

Indices cliniques :

-
-
-

Organisation du vécu :

.....

Ipséité

Indices cliniques :

-
-
-

Organisation du vécu :

.....

Mondanéité

Indices cliniques :

-
-
-

Organisation du vécu :

.....

Etape 3 - Tensions structurantes

Nom de la tension :

Traverse :

Polarité 1 :

Polarité 2 :

Permet :

Limite :

Étape 4 - Structure de vécu (formulation synthétique)

Consigne : rédiger une synthèse en quelques lignes

.....
.....
.....
.....
.....

<i>Observations</i>

Mme L., 42 ans

Mme L., 42 ans, entre dans le bureau de consultation. Elle s'assoit au bord de la chaise, sans s'adosser. Ses mains restent posées sur ses genoux, immobiles. Elle regarde par la fenêtre plus qu'elle ne regarde le clinicien. Son débit de parole est lent, avec de longs silences entre les phrases. Quand on lui pose une question, elle répond après plusieurs secondes, comme si elle devait franchir une distance pour revenir dans l'échange.

Matériau clinique brut

Organisation selon les dimensions

Spatialité

Temporalité

Corporéité

Altérité

Ipséité

Mondanéité / tonalité affective

Tension structurante

Structure de vécu

Configurations possibles

Repères cliniques

Configurations non pathologiques

Configurations psychopathologiques possibles

« *Matin sans forme* »

- « Le matin, je reste longtemps dans mon lit. Je ne dors plus vraiment, mais je ne me lève pas non plus. Je regarde mon téléphone, je fais défiler des choses sans trop les voir. »
- « Parfois je me dis que je devrais me lever, mais ça reste comme une idée un peu lointaine. Quand je finis par me lever, j'ai l'impression que la journée est déjà entamée sans moi. »

Matériau clinique brut

Organisation selon les dimensions

Corporéité / action

Temporalité

Spatialité

Altérité

Ipséité

Mondanéité (tonalité globale)

Tensions structurantes

Structure de vécu

Configurations possibles

Repères cliniques

Configurations non pathologiques

Configurations pathologiques

Madeleine, 50 ans

Madeleine, 50 ans, infirmière depuis de nombreuses années, arrive au rendez-vous avec une tenue soignée mais un visage marqué. Elle s'assoit lentement et reste quelques instants silencieuse avant de parler. Elle décrit ses journées comme très chargées, enchaînant les soins, les demandes des patients, les échanges avec les familles et les consignes de l'équipe. Elle dit avoir longtemps aimé ce rythme, se sentir utile et investie dans son travail.

Depuis quelque temps, elle évoque une difficulté croissante à se lever le matin, avec l'impression d'aborder la journée comme une suite d'actions à accomplir plutôt que comme un engagement. Elle parle de situations qui, auparavant, la touchaient, mais qui aujourd'hui la laissent indifférente ou distante. Elle dit continuer à faire ce qu'il faut, mais « sans y être vraiment ».

Le soir, elle décrit une sensation de vide, restant parfois assise sans rien faire, comme si tout effort supplémentaire était devenu impossible.

Matériau clinique brut

Organisation selon les dimensions

Corporéité

Temporalité

Spatialité

Altérité

Ipséité

Mondanéité (tonalité globale)

Tensions structurantes

Structure de vécu

Configurations possibles

Repères cliniques

Configurations non pathologiques

Configurations pathologiques

« A l'hôpital » (Henri Michaux, 1935)

« A l'hôpital »

Mon mal est atroce.

L'on m'a donné une chambre un peu à l'écart dans l'hôpital.

Je la partage avec une tousseuse.

On s'attendait sans doute à ce que par les hurlements que m'arracherait bientôt la souffrance, je détruirai le sommeil de tous les malades de la grande salle.

Non !

Chaque matin j'examine mes forces d'une part, et les progrès de mon mal d'autre part, et je me décide tant à tenir encore aujourd'hui qu'à irrévocablement le lendemain me laisser aller aux hurlements de mon infernale souffrance que je ne puis plus retenir qu'avec une peine extrême dont le trop plein est imminent, imminent, s'il n'est déjà atteint.

Cependant, le lendemain je résiste encore à la pression grandissante et déjà bien au-delà de ce que je pensais pouvoir supporter.

Mais pourquoi, pourquoi donc m'a-t-on mis une tousseuse qui me dilacère mes rarissimes moments de paix et effiloche désastreusement le peu de continuité que j'arrive encore à garder en ce terrible harcèlement du mal ?

(Henri Michaux, *La nuit remue*, Paris, Gallimard, 1935).

Matériau clinique

Organisation selon les dimensions

Corporéité

Temporalité

Spatialité

Altérité

Ipséité

Mondanéité (tonalité globale)

Tensions structurantes

Structure de vécu

Version 1 phénoménologique

Version 2 existentielle

Comparaison

Mr. D.

Lors de l'entretien, M. D. s'assoit près de la porte et garde son manteau. Il regarde régulièrement vers le couloir quand quelqu'un passe.

Il parle à voix basse, et explique qu'il préfère ne pas trop parler au téléphone, « on ne sait jamais qui peut écouter ». Il dit aussi qu'il fait attention à ce qu'il écrit dans ses messages.

Depuis quelque temps, il a remarqué que certaines personnes dans la rue le regardent « un peu trop longtemps ». « Peut-être que je me trompe », ajoute-t-il, « mais on finit par voir des choses quand on fait attention ».

Matériau clinique

Organisation selon les dimensions

Spatialité

Temporalité

Altérité

Ipséité

Corporéité

Mondanéité (tonalité globale)

Tensions structurantes

Structure de vécu

Configurations possibles

Repères cliniques

Formes non pathologiques

Formes pathologiques

« À distance des autres »

- > Le patient passe l'essentiel de ses journées seul à son domicile. Il consacre du temps à des activités individuelles, comme lire ou utiliser son ordinateur, qu'il décrit comme suffisantes pour occuper sa journée.
- > Lorsqu'il évoque ses relations, il mentionne avoir peu de contacts et ne pas ressentir le besoin d'en développer davantage. Les interactions sociales sont rares et généralement limitées à des échanges fonctionnels.
- > Il indique se sentir à l'aise dans ce mode de vie et ne rapporte pas de difficulté particulière liée à cette organisation.

Matériau clinique

Dimensions

Corporéité

Temporalité

Spatialité

Altérité

Ipséité

Mondanéité (tonalité globale)

Tensions structurantes

Structure de vécu

Configurations cliniques

Repères cliniques

Formes non pathologiques

Formes pathologiques

Le Horla - Guy de Maupassant (1887)

« Depuis quelque temps, je ne me reconnais plus entièrement dans mes gestes. Je les accomplis, mais sans y être vraiment présent.

Mon corps me répond, mais il ne m'appartient plus tout à fait. Je le regarde fonctionner avec une attention inquiète. Les actes les plus simples prennent une étrangeté nouvelle.

Cette sensation ne vient pas brutalement. Elle s'installe peu à peu, sans douleur, sans crise.

Je continue à vivre comme avant, mais avec le sentiment d'être dédoublé. Je suis là, et en même temps à côté de moi.

Le temps n'est pas rompu. Il s'écoule normalement. C'est moi qui ne m'y reconnais plus. »

Repérage du vécu

Dimensions du vécu

Tension structurante

Structure de vécu

Commentaire clinique transversal

« Vérifier, remettre en ordre »

- > La patiente décrit un ensemble de conduites de vérification répétées avant de quitter son domicile : contrôle des fenêtres et de la porte, effectués à plusieurs reprises malgré une première vérification. Ces gestes peuvent prolonger le moment du départ et entraîner des retards.
- > Au cours de la journée, elle organise ses affaires selon un ordre précis. Lorsqu'un objet n'est pas placé comme prévu, elle signale une gêne et interrompt son activité pour le remettre à sa place.
- > Elle rapporte que ces conduites lui procurent un apaisement lorsqu'elles sont réalisées conformément à ce qu'elle attend.

Matériau clinique

Dimensions

Corporéité
Temporalité
Spatialité
Altérité
Ipséité
Mondanéité (tonalité globale)

Tensions structurantes

Structure de vécu

Configurations possibles

Repères cliniques
Configurations non pathologiques
Configurations pathologiques

Approfondissement anthropo-phénoménologique

- 1. Pouvoir (le "je peux")*
 - 2. Valoir (le "cela vaut")*
 - 3. Spatialité existentielle*
 - 4. Temporalité existentielle*
 - 5. Ipséité*
 - 6. Mondanéité*
- Structure existentielle globale*

« **La salle de cours** »

- > « Quand j'arrive en amphi, je m'installe toujours au fond. Comme ça je peux partir discrètement si besoin.
- > Je regarde les autres parler entre eux, mais je ne me sens pas vraiment à ma place.
- > J'écoute le cours, mais je ne prends pas beaucoup de notes. J'attends surtout que ça se termine. »

Matériau clinique

Dimensions

Corporéité

Temporalité

Spatialité

Altérité

Ipséité

Mondanéité (tonalité globale)

Tensions structurantes

Structure de vécu

Configurations possibles

Repères cliniques

Configurations non pathologiques

Configurations pathologiques

Lecture anthropo-phénoménologique

« Quand je commence quelque chose de nouveau... »

- > « Quand je commence quelque chose de nouveau, je suis très motivé, j'ai plein d'idées, j'y pense tout le temps.
- > Mais au bout de quelques jours, je me sens débordé, comme si ça devenait trop.
- > Alors je ralentis, je fais moins, puis je laisse tomber.
- > Et après, je m'en veux un peu, parce que j'aurais aimé continuer. »

Matériau clinique brut

Organisation selon les dimensions (existenciaux)

Corporéité
Temporalité
Spatialité
Altérité
Ipséité
Mondanéité

Tensions structurantes

Structure de vécu

Configurations possibles

Repères cliniques
Configurations non pathologiques
Configurations pathologiques

Camille

Camille arrive en s'excusant d'un léger retard, parle rapidement, sourit et cherche régulièrement le regard du clinicien. Elle dit : « *Je ne sais pas trop si j'ai un problème... ça dépend des moments.* »

Elle décrit son travail : « *Quand il y a un projet, je m'implique à fond, je parle beaucoup, j'ai plein d'idées... et puis parfois, au moindre retour un peu froid, je me sens de trop. Alors je me mets en retrait... mais j'aimerais qu'on me relance.* »

À propos de ses relations : « *J'aime être avec les autres, sinon je m'ennuie. Mais avec eux, j'ai l'impression de devoir être intéressante... sinon je deviens invisible.* »

Elle ajoute : « *Quand on ne me regarde pas, j'ai l'impression de disparaître un peu.* »

Elle évoque ses relations amoureuses comme « *très intenses au début* », puis « *plus floues ensuite* ».

Ses journées alternent entre des périodes « *très actives, avec plein d'énergie* », et d'autres où « *tout retombe* » et où elle « *attend que quelque chose se passe* »

Matériau clinique brut

Organisation du vécu selon les existentiels

Corporéité (rapport au corps)

Temporalité (rapport au temps)

Spatialité (rapport à l'espace)

Ipséité (rapport à soi)

Altérité (rapport à l'autre)

Mondanéité (rapport au monde)

Tensions structurantes

Structure de vécu

Configurations possibles

Repères cliniques

Configurations non pathologiques

Configurations pathologiques

« **Décisions impossibles** »

« J'ai du mal à prendre des décisions. Même pour des choses simples, je repousse. »

« J'ai toujours l'impression que je pourrais me tromper, ou regretter. »

Du coup je laisse passer le temps, et parfois la décision se prend sans moi. Après, j'ai l'impression de ne pas vraiment choisir ma vie. »

Matériau clinique brut

Organisation selon les dimensions

Corporéité

Temporalité

Spatialité

Altérité

Ipséité

Mondanéité (tonalité globale)

Tensions structurantes

Structure de vécu

Configurations possibles

Repères cliniques

Configurations non pathologiques

Configurations pathologiques

Mr M., 28 ans

- > Mr M., 28 ans, participe à certaines activités collectives et se rend aux rendez-vous prévus. Il est présent physiquement, répond aux sollicitations et peut décrire ce qui s'est déroulé, mais rapporte par moments une impression de ne pas être vraiment impliqué dans ce qu'il vit.
- > Au cours des échanges, il indique avoir parfois l'impression d'observer la situation « comme de l'extérieur », avec une distance par rapport à ce qui se passe et à ce qu'il dit lui-même.
- > Dans son quotidien, il privilégie des activités solitaires et très organisées. Il mentionne que ces moments lui permettent de se sentir plus « rassemblé » et de réduire ces impressions de décalage.

Matériau clinique brut

Organisation selon les dimensions

Corporéité

Temporalité

Spatialité

Altérité

Ipséité

Mondanéité (tonalité globale)

Tensions structurantes

Structure de vécu

Configurations possibles

Repères cliniques

Configurations non pathologiques

Configurations pathologiques

Mme X.

- > Madame X. reçoit régulièrement des proches chez elle et veille à ce que tout soit prêt : rangement, organisation de l'espace, préparation des repas. Elle anticipe les besoins des autres et ajuste en permanence ce qui se passe pour que les échanges se déroulent sans accroc.
- > Au cours de ces moments, elle participe aux conversations, mais surveille en même temps l'ensemble de la situation : niveau sonore, circulation dans les pièces, déroulement des activités. Elle décrit rester attentive à tout ce qui pourrait nécessiter une intervention de sa part.
- > Après ces rencontres, elle rapporte une fatigue importante et le besoin de retrouver un espace calme, tout en évoquant sa satisfaction d'avoir « bien reçu » ses invités.

Matériau clinique brut

Organisation selon les dimensions

Corporéité

Temporalité

Spatialité

Altérité

Ipséité

Mondanéité (tonalité globale)

Tensions structurantes

Structure de vécu

Configurations possibles

Repères cliniques

Configurations non pathologiques

Configurations pathologiques